

Résumé du programme régional de recherche et d'action : Amérique latine et Caraïbes

Résumé analytique

Connecting Climate Minds (CCM) est une initiative financée par le Wellcome qui vise à cultiver une collaboration transdisciplinaire dans le domaine du changement climatique et de la santé mentale, avec une vision claire et alignée. Au cours de l'année écoulée, nous avons réuni des experts de différentes disciplines, secteurs et pays afin d'élaborer des programmes de recherche et d'action régionaux et mondiaux. Ces agendas définissent 1) les priorités de recherche pour comprendre et répondre aux besoins des personnes qui subissent les conséquences de la crise climatique sur leur santé mentale, et 2) les priorités pour permettre cette recherche et traduire les preuves en actions dans les politiques et les pratiques. Ce rapport résume le programme de recherche et d'action sur le changement climatique et la santé mentale dans la Région Amérique latine et Caraïbes (LAC). Le programme complet¹ a été publié séparément et est disponible [ici](#).

Au sein de la LAC, le risque d'être confronté à des problèmes de santé mentale liés au climat varie selon les zones géographiques, les caractéristiques démographiques et socioculturelles. Toutefois, les peuples autochtones, les minorités ethniques, les économies côtières et les communautés agricoles, les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes souffrant déjà de problèmes de santé mentale semblent les plus vulnérables aux problèmes de santé mentale liés au climat. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, les médecines traditionnelles et les réponses communautaires – y compris celles des groupes religieux et de ceux qui croient en une puissance au-delà de l'humanité – peuvent être des outils utiles pour relever les défis en matière de santé mentale et de bien-être liés au changement climatique dans la région.

Les thèmes de recherche prioritaires pour la région couvrent une multitude de domaines, notamment :

- **Comprendre et définir** les concepts de vulnérabilité et de résilience en matière de santé mentale liée au climat ;
- **Définir des termes diagnostiques** clés tels que l'éco-anxiété ;
- **Quantifier** le fardeau « supplémentaire » de la santé mentale associé à la crise climatique ;
- **Les perturbations dans les parcours de soins de santé mentale** résultant de la crise climatique ; et
- **Comprendre les voies et les mécanismes** par lesquels la crise climatique affecte la santé mentale en LAC, y compris :
 - **La mesure dans laquelle les modulations des indicateurs généraux socio-économiques ou de développement humain liées à la crise climatique** donnent lieu à des problèmes de santé mentale ou à des distorsions du bien-être mental ;
 - **L'impact de la chaleur sur les résultats en matière de santé mentale**, y compris les états dépressifs et l'incidence de l'automutilation ou de la mort par suicide ;
 - **La distorsion du rythme circadien** liée au climat en raison des changements dans les conditions de vie et de sommeil, et l'incidence connexe d'un mauvais bien-être mental ou d'effets sur la santé mentale chez les enfants et les populations autochtones (il s'agit des groupes identifiés comme étant vulnérables à ce problème, mais il est probable qu'il soit beaucoup plus répandu) ; et
 - **Changements de cortisol liés** au climat et apparition du stress.

La mise en œuvre d'un programme de recherche dans la Région Amérique latine et Caraïbes nécessitera une recherche respectueuse, adaptée au contexte et à la culture. Les approches participatives de la recherche seront cruciales, avec la participation des populations autochtones, des jeunes et des organisations de la société civile (en particulier lorsque les structures formelles de gouvernance nationale sont fragiles). L'engagement de membres de la communauté non professionnels en tant que cocréateurs, exécutants et diffuseurs de la recherche sera important pour garantir un sentiment d'appartenance, d'agence et d'objectif pour l'action en matière de santé mentale liée au climat, en particulier chez les jeunes.

Nous espérons que cet agenda contribuera à concentrer les efforts des communautés de financement, de politique et de pratique qui œuvrent pour un avenir où personne ne sera freiné par les problèmes de santé mentale liés au climat.

Introduction

Aléas climatiques dans la Région Amérique latine et Caraïbes

La Région Amérique latine et Caraïbes (LAC) sont confrontées à une augmentation de la fréquence et de la gravité d'une série de risques climatiques, dont les suivants, modélisés jusqu'à environ 2030 par rapport à la référence historique (généralement 1986-2005) :^{2, 3, i}

- **Températures extrêmes**, en particulier dans les régions tropicales d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et de Cuba, ainsi que dans les régions côtières du Mexique (avec des variations d'un modèle climatique à l'autre ; confiance moyenne) ;ⁱⁱ
- **Sécheresses et incendies de forêt** dans le nord de l'Argentine, dans les régions les plus peuplées du Brésil et dans certaines zones du Mexique (degré de confiance élevé) ;
- **Fortes précipitations et inondations** : l'intensité et la fréquence des précipitations extrêmes et des inondations pluviales devraient augmenter en Amérique du Sud (degré de confiance moyen à élevé), bien que l'Amérique centrale et les îles des Caraïbes soient plus susceptibles de connaître une baisse des précipitations moyennes (degré de confiance faible) ;
- **L'élévation du niveau de la mer**, qui contribue à l'augmentation des inondations côtières dans les zones de faible altitude et au recul du littoral le long de la plupart des côtes sablonneuses, en particulier autour de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud (degré de confiance élevé) ; et
- **Les cyclones tropicaux**, avec une augmentation médiane prévue d'environ 3 %.

Changement climatique et santé mentale dans la LAC

Recherche existante

Un examen approfondi réalisé dans le cadre de l'étape fondamentale de ce projet a révélé un nombre limité d'études dans la région LAC portant sur l'impact du changement climatique sur la santé mentale. Les recherches existantes fournissent des informations importantes fondées sur les contextes culturels et historiques du climat et de la santé mentale en LAC. ^{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,}

ⁱ Les projections futures sont basées sur le scénario d'émissions du milieu de la route (SSP2-4.5 Shared Socio-economic Pathway) de l'ensemble multi-modèle CMIP6 fourni dans le GIEC, 2021.

ⁱⁱ Dans le cadre du GIEC et d'autres sources importantes de projections climatiques, les niveaux de confiance sont indiqués sur une échelle de faible, moyen, élevé. Le classement se réfère à la robustesse des preuves disponibles et à la concordance entre les modèles climatiques.

¹³Cependant, de nombreuses études ont été menées après des catastrophes cycloniques majeures et ne tiennent pas compte de l'impact de la crise climatique sur la santé mentale. La littérature identifiée se concentre principalement sur les effets négatifs sur la santé mentale dus à des événements climatiques extrêmes aigus dans le contexte a) de la gravité des traumatismes/pertes observés/expérimentés, et b) des vulnérabilités socio-économiques sous-jacentes.^{4, 5, 6}

Résultats du projet Connecting Climate Minds

Les sections suivantes présentent les résultats du projet Connecting Climate Minds (CCM) – y compris le cadrage préalable au dialogue, deux dialogues, deux enquêtes et des consultations d'experts (voir l'annexe pour plus de détails sur les méthodes) – afin d'explorer : les perceptions des risques pour la santé mentale associés à l'exposition au climat ; les personnes dont la santé mentale est la plus menacée ; et les voies par lesquelles l'exposition au climat peut produire ou exacerber les problèmes de santé mentale existants. Veuillez noter que les résumés des sections suivantes sont des rapports ou des perceptions de divers experts, y compris de personnes ayant une expérience vécue, plutôt que de s'appuyer sur des données publiées.

Quelles sont les conséquences sur la santé mentale ?

Les participants au dialogue ont souligné la détresse mentale liée à la perte de biens, de moyens de subsistance ou à la migration forcée due aux crises climatiques dans de nombreux endroits de la région LAC. En outre, ils ont noté le développement du désespoir ou la perte d'un objectif à long terme chez les jeunes, ce qui – bien que cela ne soit pas explicitement mentionné – pourrait avoir un impact sur le développement de la dépression et de l'anxiété.

Qui semble être particulièrement affecté par les effets du changement climatique sur la santé mentale ?

- Les enfants
- Les communautés côtières et agricoles
- Les personnes handicapées
- Les minorités ethniques
- Groupes autochtones
- Les personnes ayant des problèmes de santé mentale préexistants
- Les personnes âgées
- Les femmes
- La jeunesse

Quels semblent être les voies et les mécanismes qui relient ces risques climatiques aux effets sur la santé mentale ?

Les événements climatiques défavorables peuvent servir de déclencheurs primaires à une cascade d'événements conduisant à des résultats socio-économiques négatifs qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé mentale (par exemple, la sécheresse peut entraîner une perte de sécurité alimentaire, ce qui peut conduire à des migrations forcées et à des déplacements, ce qui peut entraîner des vulnérabilités liées à la pauvreté, ce qui peut conduire à une mauvaise santé mentale/un mauvais bien-être mental) ou exacerber des problèmes de santé mentale existants en raison de modifications dans les parcours de soins.

Les participants ont également identifié des mécanismes biologiques possibles pour les effets directs du climat sur la santé mentale, notamment : l'impact de la chaleur sur les états dépressifs et l'incidence de l'automutilation ; la distorsion du rythme circadien liée au climat en raison des changements dans les conditions de vie et de sommeil, entraînant une mauvaise santé mentale ou un mauvais bien-être mental, en particulier chez les enfants et les populations autochtones ; et les changements de cortisol liés au climat et associés au stress. Cependant, des recherches sont nécessaires pour explorer davantage ces mécanismes.

Programme de recherche

Thèmes de recherche prioritaires

Cet agenda de recherche présente une vision alignée pour guider le domaine du climat et de la santé mentale dans la LAC. Les priorités de recherche ont été établies à la suite d'une vaste consultation d'experts dans toutes les disciplines, tous les secteurs et toutes les zones géographiques de la région, et ont fait l'objet d'une itération avec des experts régionaux et mondiaux. Elles sont présentées dans quatre catégories de recherche globales qui ont été identifiées comme des domaines où il est essentiel de poursuivre les travaux au niveau mondial, sur la base d'un premier examen de la littérature (voir l'annexe pour plus d'informations). Les thèmes de recherche prioritaires représentent des domaines dans lesquels un investissement ciblé dans la recherche pourrait permettre de dresser un tableau complet des incidences du climat sur les problèmes de santé mentale, de leurs mécanismes et de leurs solutions dans le cadre des actions en faveur de la santé mentale et du climat.

Catégorie de recherche	Thème de recherche prioritaire
Impacts, risques et groupes vulnérables	• Identifier les caractéristiques des personnes vivant dans des populations vulnérables au changement climatique dans la LAC et mesurer comment la santé mentale de ces populations est affectée par ces vulnérabilités. • Comprendre comment les populations vulnérables au climat dans la LAC perçoivent les événements climatiques extrêmes et y réagissent, et comment ces perceptions et réactions sont liées aux résultats en matière de santé mentale. <i>(Ceci est important pour les populations qui pourraient ne pas considérer le changement climatique comme négatif, telles que les personnes ayant une vision spirituelle du monde qui perçoivent le changement climatique comme normal ou attendu).</i> • Étudier le lien éventuel entre l'exposition à des événements climatiques défavorables et l'apparition de problèmes de santé mentale ou de changements dans l'état de bien-être mental d'une personne dans la LAC. • Quantifier les problèmes de santé mentale/le fardeau du bien-être mental directement attribuables au changement climatique parmi [insérer la population concernée, comme les groupes vulnérables identifiés, par exemple les communautés de pêcheurs] dans la LAC. • Mesurer l'incidence/la prévalence des changements dans [indiquer un problème de santé mentale spécifique, par exemple les idées suicidaires] ou dans le bien-être mental de base d'une personne, attribuables au changement climatique dans la région LAC. • Identifier les événements climatiques associés au risque le plus élevé d'aggravation des problèmes de santé mentale et/ou de mauvais bien-être mental au sein de la population dans la LAC.

- Identifier les facteurs sociodémographiques qui influencent la vulnérabilité aux problèmes de santé mentale liés au changement climatique dans la LAC.
- Identifier et comprendre quels facteurs de l'expérience vécue, secondaires aux événements liés au climat dans la LAC, augmentent la probabilité de problèmes de santé mentale. *(Si elle est étudiée sous un angle qualitatif, cette question peut être élargie pour évaluer l'impact du témoignage et de la réponse à un traumatisme climatique aigu, à une perte ou à un deuil lié à l'écosystème, à une violence sexuelle découlant des effets du changement climatique et à une marginalisation/stigmatisation/discrimination liée à la pauvreté et secondaire au changement climatique, comme cela a été identifié dans les dialogues).*
- Identifier et évaluer les moyens les plus efficaces de recruter et d'échantillonner des populations vulnérables au climat dans de vastes zones géographiques dans la LAC afin de faciliter la collecte de données appropriées et solides dans le cadre de la recherche sur le climat et la santé mentale.
- Identifier et évaluer des méthodes culturellement appropriées et rentables pour recueillir des données sur l'expérience vécue, axées sur la recherche de solutions, concernant la santé mentale liée au climat chez les [insérer la population concernée, par exemple les peuples autochtones] touchés par [insérer l'événement climatique, par exemple la sécheresse] dans la LAC.

Voies et mécanismes

- Mesurer la prévalence de la violence fondée sur le genre chez les femmes et les enfants marginalisés du fait du climat (y compris les personnes sans abri, les migrants ou les personnes dont le logement est précaire en raison d'événements climatiques) dans la LAC, et la manière dont cette violence affecte la santé mentale et le bien-être mental.

- Évaluer l'impact de la chaleur sur la biodisponibilité des médicaments utilisés pour traiter les troubles mentaux dans la LAC et la stabilité de ces médicaments pendant le stockage. *(Cette question explore notamment l'impact de la chaleur sur les composants actifs des médicaments et la manière dont ces composants interagissent ensuite avec les mécanismes physiologiques).*
- Évaluation de l'impact des mécanismes biologiques modifiant le cortisol sur les problèmes de santé mentale et le bien-être mental des personnes touchées par des événements climatiques défavorables dans la LAC. *(Les participants ont spécifiquement mentionné l'effet du stress lié au climat sur les niveaux de cortisol ; les effets sur d'autres hormones liées au stress pourraient également faire l'objet de recherches).*
- Analyser l'impact de [insérer tout événement climatique] sur le rythme circadien de [insérer toute population] en LAC et les effets qui en résultent sur les résultats en matière de santé mentale. *(Le rythme circadien fait référence aux cycles physiologiques de sommeil et d'éveil ; cette question explore les effets sur la santé mentale des perturbations qui peuvent survenir dans les hormones associées en raison des changements de ce rythme dus à des facteurs climatiques tels que la chaleur ou le déplacement d'un logement/abri à la suite d'une catastrophe climatique, etc.)*

Avantages de l'action climatique (adaptation et atténuation) pour la santé mentale

- Identifier les interventions les plus efficaces pour encourager l'action communautaire collective en matière d'adaptation au climat et d'atténuation de ses effets, de manière à améliorer également les résultats en matière de santé mentale (par exemple, l'action collective autour de la réponse aux catastrophes, l'action collective pour améliorer les espaces verts/les projets de plantation d'arbres, etc.) dans la LAC.

- Identifier et évaluer les interventions les plus efficaces pour promouvoir le plaidoyer et l'agence en tant qu'outil pour favoriser la résilience climatique chez les jeunes dans la LAC et évaluer les implications de ces interventions sur les résultats en matière de santé mentale.
- Identifier les obstacles à la sensibilisation à l'impact du climat sur la santé mentale parmi les populations vulnérables au climat dans la LAC.
- Identifier et évaluer des activités d'éducation ou de sensibilisation au changement climatique culturellement appropriées, accessibles et abordables, susceptibles d'améliorer les résultats en matière de santé mentale pour les populations vulnérables au climat dans la LAC.
- Identifier des mécanismes peu coûteux pour partager efficacement des informations sur les risques climatiques avec les populations vulnérables (y compris dans le cadre de l'éducation formelle et informelle) dans la LAC et évaluer l'impact de ces informations sur les résultats en matière de santé mentale.

(Cette recherche devrait inclure l'identification et l'évaluation des structures existantes d'échange d'informations dans les domaines de la santé mentale ou du climat, par exemple en s'appuyant sur les systèmes d'alerte d'urgence en cas de catastrophe).

- Évaluer le potentiel de modification des stratégies existantes de communication sur les risques de catastrophes (qui sont utilisées pour aider à minimiser les effets sur la santé mentale des catastrophes climatiques dans les régions vulnérables au climat) afin de traiter les effets sur la santé mentale des menaces climatiques rampantes et aiguës dans la LAC.
- Identifier et évaluer les mécanismes de survie à la sécheresse et/ou de gestion de l'utilisation des terres utilisés par les populations autochtones dans la LAC et leur potentiel pour minimiser la détresse mentale et améliorer les résultats en

matière de santé mentale pour les populations touchées par le changement climatique.

(L'événement climatique peut être modifié pour cette question).

Interventions/solutions en matière de santé mentale dans le contexte du changement climatique

- Évaluer l'impact des pratiques quotidiennes de pleine conscience ou spirituelles sur les problèmes de santé mentale et le bien-être mental parmi les [insérer une sous-population, par exemple, Calinago] dans la LAC en réponse à [insérer l'événement climatique d'intérêt].
- Identifier et évaluer l'efficacité des plantes médicinales et des graines créoles utilisées par les populations autochtones pour minimiser ou réduire les problèmes de santé mentale causés par le changement climatique dans [insérer une région spécifique] et comprendre les implications d'un climat changeant pour leur utilisation et leur disponibilité.
- Identifier les moyens les plus efficaces pour une action interdisciplinaire et multisectorielle afin de soutenir les interventions en matière de climat et de santé mentale dans la LAC.
- Identifier et évaluer les politiques et les mécanismes de financement partagés (entre le climat et la santé mentale) dans la région pour soutenir la recherche à l'intersection de la santé mentale et du climat dans la LAC.
- Comprendre a) comment les personnes souffrant de problèmes de santé mentale se connectent aux services de soins dans la LAC, b) si cela change dans le contexte des crises liées au climat, c) si cela change, comment les résultats sont affectés, et d) la meilleure façon de fournir des soins appropriés et continus.
- Identifier et évaluer les interventions collectives et communautaires les plus bénéfiques pour protéger la santé mentale et le bien-être mental dans le contexte de la crise climatique dans la LAC.

- Comprendre le rôle de la religion et de la spiritualité (confiance dans l'existentiel) dans la contextualisation/expérience des défis de santé mentale liés au changement climatique dans la LAC, et comment en tenir compte de manière appropriée dans l'élaboration et la mise en œuvre des interventions.
- Identifier les partenariats multi-systèmes les plus efficaces pour traiter les déterminants sociaux, économiques et commerciaux combinés des problèmes de santé mentale et/ou du mauvais bien-être mental qui peuvent s'aggraver en raison des menaces climatiques aiguës et chroniques. *(Cette question est incluse pour souligner la nécessité d'une action multisectorielle et systémique pour étudier et traiter l'impact de la crise climatique sur la santé mentale).*
- Comprendre la nature et l'efficacité des pratiques d'autogestion et de résilience des populations indigènes en ce qui concerne [insérer l'événement indésirable] et [insérer le résultat intéressant en matière de santé mentale].

Programme d'action

Ce programme d'action définit une vision commune qui servira de point de ralliement au domaine de la santé mentale et du changement climatique dans la LAC. Il présente les défis à relever, les opportunités à exploiter et les actions prioritaires à mettre en œuvre pour créer un domaine prospère en matière de climat et de santé mentale.

Vision régionale de la santé mentale dans un climat en mutation

Nous envisageons un avenir où, grâce à des actions correctives collectives, les effets de l'homme sur le changement climatique seront inversés ou minimisés. Les résultats en matière de santé mentale liée au climat sont améliorés par la réduction des risques climatiques et la création d'une politique et d'une infrastructure sociale favorables ; cela inclut la recherche interdisciplinaire participative et de meilleurs services de diagnostic et de traitement pour les problèmes de santé mentale liés au climat.

Créer un environnement propice à la recherche et traduire en actions une base de données de plus en plus étoffée

	Créer un environnement favorable à la recherche à l'intersection du changement climatique et de la santé mentale	Traduire une base de données de plus en plus étoffée en actions susceptibles de répondre aux effets du changement climatique sur la santé mentale
Défis	• Manque de consensus sur les termes clés • Absence de validation des outils • Absence ou utilité limitée des systèmes de surveillance ou des registres pour les données relatives à la santé mentale • Manque possible de compréhension de la présentation des manifestations retardées de la santé mentale après une catastrophe, entraînant des diagnostics tardifs • Financement	• La santé mentale et le changement climatique sont des questions de santé publique relativement nouvelles ; par conséquent, elles ne figurent pas nécessairement dans les programmes d'action politique et sociale • Stigmatisation générale de la société à l'égard de la santé mentale, qui pose des problèmes de sensibilisation et de définition des priorités au niveau politique
Opportunités et facilitateurs	• Partenariat avec des institutions existantes, telles que l'université de Sao Paulo ou l'Université Fédérale de Rio Grande do Sul, afin de concevoir et d'exécuter des recherches dans des cadres universitaires et non universitaires • Tirer parti des travaux actuellement commandés	• Exploiter l'intérêt actuel dans le domaine • Mettre l'accent sur les situations de crise climatique aiguës pour souligner l'urgence d'une réponse et la nécessité de solutions à long terme • Tirer parti de la préparation des communautés et de l'action collective

	par de grands groupes internationaux dans des domaines connexes, tels que la sécurité alimentaire, dans la région	
Partenaires potentiels pertinents	• Organisations de la société civile • Groupes d'expérience vécue • Divers professionnels de la santé • La jeunesse	• Parties prenantes au niveau de l'État/du gouvernement, y compris les ministères de l'environnement et des services de santé • Les parties prenantes non gouvernementales, notamment les représentants des écoles, des universités, des communautés côtières et montagnardes, des personnes handicapées, des organisations de santé mentale, des églises, des communautés agricoles et des pêcheurs, des associations de femmes et de victimes, et des organisations de base • Les entreprises du secteur privé susceptibles, ou perçues comme susceptibles, d'avoir un impact négatif sur les écosystèmes de la région (par exemple, les producteurs d'engrais, l'agro-industrie et les grands consommateurs de terres et d'eau) • Entités internationales, telles que les agences des Nations unies, les organisations de femmes, les associations médicales, les associations psychologiques et les centres de recherche

Prochaines étapes prioritaires/recommandations aux investisseurs et aux acteurs

Créer un environnement favorable à la recherche à l'intersection du changement climatique et de la santé mentale

Compte tenu des multiples facteurs qui influencent l'interaction entre le changement climatique et la santé mentale dans la LAC, les bailleurs de fonds, les chercheurs et les décideurs politiques devraient s'efforcer d'adopter d'urgence une approche multisectorielle qui considère fondamentalement que la gestion des ressources de la planète est indissociable de la poursuite du développement humain et du bien-être.

Les institutions de financement devraient :

- Créer des pools communs à des institutions de divers secteurs afin d'accroître les financements/ressources disponibles (par exemple, mettre en commun les ressources des financeurs traditionnels de la santé et des financeurs traditionnels de la recherche sur les mesures de sécurité).
- Créer des allocations dédiées au climat et à la santé mentale dans le cadre des flux de financement existants explicitement à long terme (par exemple, la recherche en matière de politique alimentaire).

Les institutions de financement et de recherche devraient donner la priorité aux projets qui :

- Créer ou renforcer les systèmes de surveillance de la santé mentale et du climat ; cela permettra de mieux comprendre les interactions entre le climat épidémiologique et la santé mentale dans la région.
- Créer et valider des outils de diagnostic du climat et de la santé mentale (par exemple, ceux nécessaires pour l'éco-anxiété).
- Contenir des éléments pratiques permettant d'améliorer la santé mentale et/ou le bien-être mental dans le contexte du changement climatique au niveau communautaire (de préférence avec une durabilité démontrable et un impact communautaire élevé).

Traduire une base de données de plus en plus étoffée en actions susceptibles de répondre aux effets du changement climatique sur la santé mentale

Les décideurs politiques devraient :

- Créer des mécanismes pour améliorer l'éducation et la formation médicales dans le domaine du climat et de la santé mentale.
- Intégrer le climat et la santé mentale dans les politiques/composantes prioritaires du système de santé (par exemple, le climat et la santé mentale dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, des soins de santé primaires et des réponses aux pandémies).

Les bailleurs de fonds, les décideurs politiques et les chercheurs devraient :

- Réfléchir et concevoir des moyens culturellement appropriés pour traduire les données probantes dans des contextes géographiques, des groupes de population et des langues variés.
- S'engager auprès des médias et d'autres acteurs pour soutenir la traduction des données probantes.
- Investir dans des campagnes de sensibilisation organisées sur le climat et la santé mentale dans la région afin de réduire la stigmatisation.

Conclusion

Les participants de la région LAC perçoivent et subissent des menaces multiples et variées pour la santé mentale et le bien-être mental en raison d'événements climatiques rampants et aigus. Compte tenu de l'intensité croissante de ces menaces, nous devons établir ensemble des principes fondamentaux pour concevoir des interventions fondées sur des données probantes en matière de climat et de santé mentale, soutenues par une plateforme de diffusion et de mise en œuvre de ces interventions. La réalisation de ces objectifs nécessitera une approche systémique, intersectorielle et interdisciplinaire, et devrait inclure un large éventail de parties prenantes dès les premières étapes. Cette tâche nécessitera un soutien important de la part des acteurs et des bailleurs de fonds régionaux et internationaux, mais elle peut être accomplie grâce à une action unifiée et à des méthodes de travail respectueuses et inclusives.

Qui a produit ce rapport

Équipe d'auteurs

Dr Natalie Greaves, maîtresse de conférences en santé publique, coordinatrice du Master de philosophie/doctorat en santé publique et épidémiologie, Faculté des sciences médicales, Université des Indes occidentales (UWI) Cave Hill.

Dr Satish Jankie, maître de conférences en pharmacologie, École de pharmacie, Faculté des sciences médicales, UWI St. Augustine

Dr Shamjeet Singh, maître de conférences en sciences fondamentales intégrées de la santé, École de pharmacie, Faculté des sciences médicales, UWI St. Augustine
Ambassadrice Gillian M. S. Bristol, Directeur du Centre latino-américain des Caraïbes (LACC), UWI Mona

Dr Elizabeth Mandeville, consultante indépendante

Dr Michael Campbell, maître de conférences en sciences du comportement/psychologie et vice-doyen (Recherche et Etudes Supérieures), UWI Cave Hill

Nienke Meinsma, chargée de cours sur le changement climatique et la politique de santé, Centre Climate Cares, Institut d'innovation en santé mondiale, Collège impérial de Londres

Jessica Newberry Le Vay, chargée de recherche sur le changement climatique et la politique de santé, Centre Climate Cares, Institut d'innovation en santé mondiale, Collège impérial de Londres

Didi Thompson, chercheur honoraire, Centre de politique de santé, Institut d'innovation en santé mondiale, Collège impérial de Londres

Dr Emma J. Lawrance, Centre Climate Cares, Institut d'innovation en santé mondiale, Collège impérial de Londres

Dr Sandeep Maharaj, Directeur, École de pharmacie, Faculté des sciences médicales, UWI St. Augustine

Il s'agit d'un travail indépendant réalisé par les auteurs avec le soutien et la contribution de l'équipe Connecting Climate Minds.

Remerciements

L'équipe Connecting Climate Minds pour l'Amérique latine et les Caraïbes remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette étude. La diversité géographique de la région a rendu la tâche difficile à certains participants, et nous exprimons nos plus sincères remerciements à ceux qui ont donné de leur temps et de leur expertise.

Adrian Trotman
Alejandro Herrera-Aguayo
Ana Gabriela Mejia
Ana Sfoggia
Antonia Faustina Xuruc Barreno
Antônio Saraiva
Athena Adoración Flores Torres
Bidyadhar Sa
Carlos Arroyo
Carolina Somarribas Dormond
Cesar Castillo
Chris Oura
Claudia Buchweitz
Cleefedwens Fortuné
Danelia Pineda
Darren K. Dookeeram
Doris Keens-Douglas
Edward Mark
Olga Falceto
Felipe Nora
Frandy Jules
Gabriela Aurora Martínez Ramírez
Garvey Myrvelt Louis Jean
Georgiana Gordon-Strachan
German Casco
Gloria Blaise
Grace Kelly Bent
Hariharan Seetharaman
Harvey Vijay Sharma
Heather Armstrong
Jacqueline Laguardia Martinez
Jean Mary Alexandre
Jeremy Collymore

Jonathan Sherin
Katherin Vivianne Fuentes Rodríguez
Kenzy Jean Pierre
Lisa Benjamin
Marcela De la Garma
Marcia Mandepora Chundary
Mayara Floss
Michael H. Campbell
Nelzair Araujo Vianna
Norton Gilberto Chavarria Francis
Raquel Tupinambá
Renato Oliveira e Souza
Rolando Sierra
Rosa Elizabeth Flores Gómez
Salvador López
Sandra Reid
Satish Jankie
Serafina Espinoza Blanco
Shamjeet Singh
Shane Kirton
Silvel Elías
Vashti-Eve Burrows
Vilma Crovetto
Vinson Bradley Noel
Xóchitl Garza Olivares

En outre, le travail n'aurait pas pu être accompli sans l'expertise, la diligence, l'intérêt et le soutien des coresponsables, des personnes ayant une expérience vécue et des jeunes ambassadeurs.

Les personnes ayant un rôle inaugural de leadership :
Ambassadrice Gillian Bristol et Dr Sandeep Maharaj.

Co-coordonateurs et facilitateurs : Dr Enrique Falceto de Barros, docteur chercheur Msc Marcos Leonardo Williamson Cuthbert, Dr Marta Rosa Munoz, Dr Fresia Hernandez, Dr Dassaëve Brice, Dr Clemencia Ramirez, Dr Tatiana Camargo, Dr Raquel Santiago et Professeur Jonathan Sherin.

Groupe de l'expérience vécue : Mme Vashti-Eve Burrows, Mme Gloria Blaise, Mme Raquel Tupinamba, et Mme Norton Chavarria.

Ambassadeurs de la jeunesse : Mme Ana Gabriela Mejia et M. Harvey Vijay Sharma.

Analystes de recherche : Dr Satish Jankie et Dr Shamjeet Singh.

L'équipe remercie également le Dr Natalie Greaves pour son expertise technique et pour avoir dirigé l'analyse des données qualitatives présentées dans ce rapport.

Financement

Ce projet a été financé par Wellcome.

Conflits d'intérêts

Les auteurs n'ont aucun conflit d'intérêt à déclarer.

Traductions

Merci à Climate Cardinals pour les traductions.



Annexe

Vue d'ensemble du CCM

Connecting Climate Minds (CCM) est un projet financé par Wellcome et lancé en 2023 pour développer un programme inclusif de recherche et d'action sur le changement climatique et la santé mentale. Le projet a deux objectifs principaux, étroitement liés. La première consiste à élaborer un programme de recherche et d'action harmonisé et inclusif, fondé sur les besoins des personnes ayant vécu des problèmes de santé mentale dans le contexte du changement climatique, afin d'orienter les travaux dans ce domaine au cours des prochaines années. La seconde consiste à lancer le développement de communautés de pratique connectées pour le changement climatique et la santé mentale dans sept régions du monde (désignées par les objectifs de développement durable), équipées pour mettre en œuvre ce programme. Nous visons à combiner les forces d'une perspective mondiale et d'une orientation régionale, et à rassembler diverses perspectives disciplinaires dans une vision commune qui peut garantir que la recherche est efficace pour combler les lacunes prioritaires en matière de preuves et informer les changements dans les politiques et les pratiques à l'intersection du changement climatique et de la santé mentale.

Structure de l'équipe communautaire régionale

Dans la LAC, le CCM est dirigée par une équipe communautaire régionale (ECR), chargée de réunir diverses compétences dans la région et de renforcer la capacité régionale à créer et à mettre en œuvre le programme de recherche et d'action. La structure de l'ECR est décrite ci-dessous.

Structure de l'ECR	Rôle	Membres
Coordinateur communautaire régional (CCR)	Responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre des activités du projet dans la région, y compris la convocation et le soutien d'une communauté régionale d'expertise diversifiée.	Chef d'équipe du projet : Ambassadrice Gillian Bristol , Centre latino-américain des Caraïbes (LACC), Vice-Chancellerie, UWI Mona, Jamaïque

		Chercheur principal/Responsable de projet : Dr Sandeep Maharaj, Campus UWI St. Augustine, Conseiller technique : Dr Natalie Greaves, UWI Cave Hill Chercheur assistant : Dr Shamjeet Singh, UWI St. Augustine Chercheur assistant : Dr Satish Jankie, UWI St. Augustine Communications /administration : Mme Lina Torres Maestre Coordinatrice : Mme Chandika Ganesh Assistante : Mme Jacinth Seemungal
Co-coordinatrice	Apporter une expertise supplémentaire dans toutes les disciplines et dans tous les pays, fournir des conseils et des examens techniques, et soutenir l'exécution des projets.	Professeur Enrique Falceto De Barros, directeur de WONCA (Organisation mondiale des médecins de famille) Programme de troisième cycle en enseignement des sciences (PPGECI) à l'Université fédérale du Rio Grande do Sul (UFRGS) M. Marcos Williamson, Chercheur en éducation et Directeur du centre d'information sur l'environnement de l'<u>Université des régions autonomes de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN)</u>, Nicaragua. Dr Martha Rosa Munoz, Directrice de FLACSO Cuba -

		Faculté latino-américaine des sciences sociales (FLACSO), Cuba Dr Fresia Hernandez, Directrice nationale du programme de psychologie clinique et de la santé au Centre technologique de Monterrey (TEC), Mexique Dr Dassaëve Brice, EarthMedic et EarthNurse Haïti Dr Clemencia Ramirez, Consultante indépendante, Organisation internationale pour les migrations (OIM) Coordinateurs adjoints/Facilitateurs du dialogue : Dr Tatiana Camargo, Centre brésilien de santé planétaire à l'Université de Sao Paulo et à l'Université fédérale de Rio Grande do Sul. Dr Raquel Santiago, Santé Planétaire (PH) Brésil, IEA/USP Professeur d'université Jonathan Sherin, Healthy Brains Global Initiative
Groupe consultatif sur l'expérience vécue (LEAG)	Conseil consultatif d'experts ayant une expérience vécue des problèmes de santé mentale dans le contexte du changement climatique et/ou appartenant à des groupes de population vulnérables et vivant avec des risques climatiques. En s'appuyant sur leur expertise et	Mme Vashti Burrows, Bahamas Mme Gloria Blaise, Haïti Mme Raquel Tupinamba, Conseil indigène Tupinamba de Baixo Tapajos/Amazonie, M. Norton Chavarria, Communauté de Karata, Nicaragua

	leur sagesse uniques, les groupes consultatifs sur l'expérience vécue fournissent des perspectives et des conseils essentiels, centrés sur la communauté, qui influencent l'approche globale et les résultats du projet.	
Ambassadeurs de la jeunesse	Jeunes conseillers (âgés de 18 à 29 ans) ayant une expérience vécue des problèmes de santé mentale dans le contexte du changement climatique et/ou appartenant à des groupes de population vulnérables et vivant avec des risques climatiques. Les ambassadeurs de la jeunesse apportent des perspectives uniques, centrées sur les jeunes, à l'élaboration et à la mise en œuvre des activités du projet.	Mme Ana Gabriela Mejia – Équateur M. Harvey Vijay Sharma – Guyane

Méthodes

Nous avons élaboré ce programme de recherche et d'action à l'aide d'une méthodologie solide et inclusive afin de saisir, de combiner et d'affiner une grande diversité de points de vue tout en favorisant les liens au sein d'une communauté de pratique en plein essor. Des experts de différentes disciplines, secteurs et pays ont été réunis dans le cadre de deux dialogues virtuels et consultés par le biais de deux enquêtes en ligne.

L'équipe centrale du CCM a développé cette méthodologie au niveau mondial en consultation avec l'ECR, un Conseil consultatif mondial et Wellcome. Les méthodes et le matériel ont été adaptés au niveau régional par l'ECR afin d'assurer un équilibre entre la normalisation mondiale et l'adéquation et la flexibilité régionales. Le partage permanent des processus, des enseignements et des défis entre les régions a facilité le développement itératif de la

méthodologie. Le processus d'élaboration des agendas régionaux de recherche et d'action est présenté ci-dessous.

Les participants ont été recrutés tout d'abord par le biais des réseaux de l'ECR, de l'équipe centrale du CCM et de Wellcome, puis par un échantillonnage en boule de neige afin d'atteindre un large éventail d'experts dans toutes les disciplines, tous les secteurs et toutes les zones géographiques.

Les méthodes complètes peuvent être consultées [ici](#).

Cadrage et formulation de l'évaluation au niveau mondial Cartographie des parties prenantes, disciplines et secteurs pertinents Examen de la base de données universitaires actuelle et du contexte politique actuel Développement d'un cadre global de catégories de recherche Formation d'un Conseil consultatif mondial pour conseiller sur l'élaboration de programmes de recherche et d'action mondiaux et régionaux Janvier – Mars 2023	Cadrage et mise en contexte Collecte de données sur l'expérience vécue Examen de la portée de la littérature existante au niveau régional Cartographie des aléas climatiques Entrevues avec des informateurs clés Enquête préalable au dialogue avec des experts régionaux invités au dialogue Mars–Septembre 2023	Identification des domaines prioritaires de recherche Dialogue 1 avec divers experts régionaux pour faire ressortir les besoins pertinents et discuter des priorités de recherche Analyse et synthèse des données issues du dialogue 1 pour générer des ébauches de priorités de recherche Août–Octobre 2023	Affiner les priorités de recherche Dialogue 2 avec des experts régionaux pour obtenir des commentaires sur les priorités de recherche et identifier les voies de mise en œuvre et d'application de la recherche Analyse et synthèse des données du dialogue 2 pour affiner les priorités de recherche Enquête auprès d'experts régionaux pour partager des priorités de recherche affinées, obtenir d'autres commentaires et une contribution régionale plus large Examen et consultation d'experts régionaux et mondiaux Octobre–Décembre 2023	Programme mondial de recherche et d'action Formation d'un groupe de travail d'experts en analyse globale Synthèse de sept programmes régionaux, du programme des nations et des peuples autochtones, du programme des jeunes et du programme des petits agriculteurs et des pêcheurs dans un projet de programme mondial. Événement mondial afin de réunir des experts pour la finalisation et l'approbation le programme mondial de recherche et d'action Janvier–Avril 2024
--	--	---	--	---

Génération de priorités de recherche et d'action

Les priorités de recherche ont été définies, affinées et finalisées selon le processus suivant :

- Développer des catégories de recherche :** À travers une analyse globale des études existantes sur le changement climatique et la santé mentale,^{14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23} quatre grandes catégories de recherche ont été identifiées comme des domaines où il est essentiel de poursuivre les travaux à l'échelle mondiale. Ce cadre a été utilisé comme base pour structurer les discussions au sein des dialogues afin de générer des priorités de recherche et a constitué le cadre de codage global pour l'analyse. Ces priorités sont les suivantes :

- **Impacts, risques et groupes vulnérables :** Améliorer notre compréhension de la manière dont la santé mentale est affectée par le changement climatique. Par exemple : quels résultats en matière de santé mentale sont affectés ou menacés ; la prévalence, la gravité, les coûts économiques et sociétaux de ces impacts ; et qui est le plus vulnérable à ces impacts.
- **Voies et mécanismes :** Améliorer notre compréhension de la manière dont la santé mentale est affectée par le changement climatique et, en particulier, déterminer s'il existe des facteurs spécifiques au changement climatique qui augmentent les risques pour la santé mentale. Il s'agit notamment d'examiner les voies et les mécanismes biologiques, psychologiques, sociétaux ou environnementaux.
- **Avantages de l'action climatique (adaptation et atténuation) pour la santé mentale :** Comprendre et quantifier quand et comment les mesures d'adaptation et d'atténuation du climat, dans tous les secteurs, peuvent également avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale.
- **Interventions/solutions en matière de santé mentale dans le contexte du changement climatique :** Identifier les interventions/solutions/actions les plus efficaces pour soutenir la santé mentale dans le contexte du changement climatique, dans divers secteurs. Il s'agit d'apporter un soutien aux personnes qui subissent déjà des effets négatifs sur leur santé mentale et de réduire le risque ou la gravité des effets négatifs futurs sur la santé mentale.
- **Générer des thèmes de recherche prioritaires :** Les participants au Dialogue 1 ont été guidés dans une discussion structurée pour faire émerger leurs points de vue sur 1) les conséquences émergentes et probables sur la santé mentale des risques climatiques actuels et futurs pertinents au niveau régional et les possibilités d'actions bénéfiques pour la santé mentale et le climat, et 2) les domaines dans lesquels des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre et répondre aux conséquences et aux possibilités identifiées.
- **Analyse :** Les données du dialogue (transcriptions des séances de discussion et notes) ont été analysées à l'aide de la méthode du cadre²⁴ – une approche basée sur une matrice qui permet aux chercheurs qualitatifs d'entreprendre un examen approfondi des transcriptions et des notes écrites.
- **Projets de thèmes de recherche prioritaires :** Cette matrice a été utilisée en combinaison avec les données issues du cadrage pré-dialogue (entretiens/analyse de la littérature/enquête pré-dialogue) mené dans la région pour dresser une liste des

thèmes de recherche prioritaires. Ils ont été affinés par la consultation de l'ECR et par la triangulation des notes de discussion, des transcriptions, de l'évaluation de la portée du pré-dialogue et de la consultation d'experts.

- **Affiner les thèmes de recherche prioritaires :** Les thèmes de recherche ont été communiqués aux participants du dialogue 2 pour recueillir leurs commentaires. Les thèmes de recherche ont été affinés en fonction de ce retour d'information et partagés avec les participants au dialogue et un échantillon plus large d'experts dans le cadre de l'enquête post-dialogue.
- **Finalisation des thèmes de recherche prioritaires :** Une liste finale de thèmes de recherche prioritaires a été établie sur la base des commentaires de l'enquête post-dialogue, de la consultation de l'ECR et des experts régionaux, de l'équipe centrale du CCM, du Conseil consultatif mondial et de Wellcome.

Les priorités d'action ont été définies, affinées et finalisées selon le processus suivant :

- **Développer des catégories d'action :** La consultation d'experts au sein de l'équipe mondiale du CCM a permis de définir deux catégories d'actions prioritaires de haut niveau. Ces priorités sont les suivantes : 1) créer un environnement propice à la recherche à l'intersection du changement climatique et de la santé mentale et 2) traduire une base de données de plus en plus étoffée en actions susceptibles de répondre aux effets du changement climatique sur la santé mentale. Au sein de chacune d'entre elles, des sous-catégories ont été créées : 1) un état futur souhaité, 2) des opportunités et des catalyseurs, 3) des défis, et 4) des partenaires et des parties prenantes.
- **Générer des actions prioritaires :** Les participants au Dialogue 2 ont été conduits à travers une discussion structurée pour faire émerger leurs points de vue sur 1) la manière dont le programme de recherche sur le changement climatique et la santé mentale pourrait être mis en œuvre au mieux dans la région et 2) la manière dont une base de données croissante pourrait être traduite en action dans la politique et la pratique.
- **Analyse :** Les données du dialogue (transcriptions des réunions en petits groupes et notes) ont été analysées à l'aide de la méthode du cadre (décrite ci-dessus).
- **Finalisation des actions prioritaires :** Un programme d'action résumant les enseignements du dialogue 2 et décrivant les actions prioritaires identifiées a été élaboré sur la base d'une consultation avec l'ECR et les experts régionaux, l'équipe centrale du CCM, le conseil consultatif mondial et Wellcome.

Participants

Les participants au dialogue formaient un groupe diversifié en termes de répartition géographique, de sexe, de secteur et de discipline. Tous les participants ont été invités aux deux dialogues, mais dans certains cas, les participants n'ont pas pu assister aux deux dialogues.

Au total, 45 participants ont assisté au dialogue 1 et 30 au dialogue 2. Les tableaux ci-dessous présentent une répartition des caractéristiques des participants.

Répartition géographique

	Dialogue 1		Dialogue 2	
<u>Pays</u>	<u>Nomb re</u>	<u>Pourcent age</u>	<u>Nomb re</u>	<u>Pourcent age</u>
Bahamas	1	2,5 %	1	3,80 %
Barbade	1	2,5 %	1	3,80 %
Bolivie (État plurinational de)	1	2,5 %	0	0 %
Brésil	4	11 %	5	19 %
Chili	2	5 %	0	0 %
Costa Rica	1	2,5 %	1	3,80 %
Équateur	1	2,5 %	0	0 %
Grenade	2	5 %	0	0 %
Guatemala	1	2,5 %	1	3,80 %
Haïti	4	11 %	5	19 %
Honduras	3	8 %	0	0 %
Jamaïque	3	8 %	2	8 %
Mexique	3	8 %	1	3,80 %
Nicaragua	3	8 %	2	8 %
Sainte-Lucie	1	2,5 %	0	0 %
Trinité-et-Tobago	5	13 %	7	27 %
États-Unis d'Amérique	2	5 %	0	0 %

Expertise

	Dialogue 1		Dialogue 2	
<u>Expertise</u>	<u>Nomb re</u>	<u>Pourcent age</u>	<u>Nomb re</u>	<u>Pourcent age</u>
Changement climatique	12	21 %	7	19 %
Santé mentale	13	23 %	11	29,7 %

Soins de santé	18	31,5 %	14	37,8 %
Autre	14	24,5 %	5	13,5 %
Je ne sais pas / Je préfère ne pas me prononcer	0	0 %	0	0 %

Discipline

	Dialogue 1		Dialogue 2	
<u>Discipline</u>	<u>Nomb re</u>	<u>Pourcent age</u>	<u>Nomb re</u>	<u>Pourcent age</u>
Activisme	5	4,5 %	4	5 %
Communauté	13	12 %	9	11 %
Education	21	19 %	17	21 %
Expert à travers ma propre expérience vécue	5	4,5 %	4	5 %
Financement	1	1 %	0	0 %
Soins de santé	16	14,5 %	12	15 %
Organisation Non Gouvernementale	13	12 %	9	11 %
Politique	4	3,5 %	4	5 %
Recherche	25	23 %	19	24 %
Autre	7	6 %	2	3 %

Genre

	Dialogue 1		Dialogue 2	
<u>Genre</u>	<u>Nomb re</u>	<u>Pourcent age</u>	<u>Nomb re</u>	<u>Pourcent age</u>
Hommes	8	36 %	12	46 %
Femmes	13	59 %	14	54 %
Non-binaire	1	5 %	0	0 %

Participants à l'enquête :ⁱⁱⁱ

Enquête pré-dialogue : 76

ⁱⁱⁱVeillez noter que les chiffres sont approximatifs et ne tiennent pas compte des réponses doubles ou incomplètes.

Éthique, collecte et stockage des données

Éthique

Cette étude a été examinée et a reçu un avis favorable du comité d'éthique de la recherche du Collège Impérial (titre de l'étude : « Dialogues mondiaux pour établir un programme de recherche réalisable et construire une communauté de pratique sur le changement climatique et la santé mentale ») ; numéro d'identification de l'étude : 6522690. En outre, le protocole de l'étude, avec les adaptations locales nécessaires, a été examiné et approuvé par le Comité d'examen institutionnel de l'UWI St. Augustine [CREC-SA. 2298/08/2023].

Stockage et partage des données

Les dialogues ont été menés virtuellement sur Zoom avec le consentement éclairé de tous les participants. Les dialogues et les groupes de discussion ont été enregistrés et transcrits par des prestataires tiers (Way with Words et Absolute Translations). La distribution de l'enquête et la collecte des données ont été effectuées à l'aide de la plateforme en ligne Qualtrics. Les données ont été stockées et gérées par le Collège Impérial de Londres à l'aide d'un serveur sécurisé. L'UWI était un contrôleur de données conjoint pour les données fournies à ce projet pour la LAC et responsable du stockage et du partage sécurisés des données avec le Collège Impérial de Londres et les équipes d'analystes régionaux. Les données seront conservées par le Collège Impérial de Londres pendant 10 ans après la fin de l'étude.

Glossaire

Le changement climatique, la santé mentale et leur intersection sont des domaines complexes et étendus. Pour les besoins de cet agenda, nous définissons la portée de ces termes comme suit.

Par **problèmes de santé mentale**, nous entendons des pensées, des sentiments et des comportements qui affectent la capacité d'une personne à fonctionner dans un ou plusieurs domaines de la vie et qui impliquent souvent des niveaux importants de détresse psychologique. Il s'agit notamment de l'anxiété, de la dépression, du stress post-traumatique, de la psychose, des pensées suicidaires et de la toxicomanie.

Par **expérience des effets du changement climatique**, nous entendons : 1) subir les effets directs des risques climatiques, tels que des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses, des feux de forêt/incendies de brousse, des sécheresses, des inondations ou des tempêtes (par exemple, des typhons, des ouragans, des cyclones), et 2) subir des perturbations des déterminants sociaux et environnementaux d'une bonne santé mentale, tels que l'obligation de déménager, l'impossibilité d'accéder à la nourriture ou à l'eau, la perte des moyens de subsistance ou des terres d'origine, ou la perturbation des pratiques culturelles à la suite du changement climatique.

Les défis en matière de santé mentale dans le contexte du changement climatique sont les suivants :

- Comment le changement climatique pourrait aggraver les problèmes de santé mentale préexistants.
- Comment le changement climatique peut contribuer à la prévalence ou à l'impact des problèmes de santé mentale existants.
- Comment le changement climatique peut avoir un impact sur l'accès ou l'efficacité des traitements pour les personnes souffrant de problèmes de santé mentale.
- Comment le changement climatique peut entraîner de nouveaux problèmes de santé mentale.

Un glossaire décrivant les concepts et les mots clés pertinents pour les programmes de recherche et d'action « Connecting Climate Minds » peut être téléchargé [ici](#).

Références

- ¹ Greaves, N. *et al.* *Regional research and action agenda: Latin America and the Caribbean*. (Wellcome, 2024).
- ² Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). *Climate Change 2021 – The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. (Cambridge University Press, 2023).
- ³ Knutson, T. *et al.* Tropical Cyclones and Climate Change Assessment: Part II: Projected Response to Anthropogenic Warming. *Bulletin of the American Meteorological Society* **101**, E303–E322 (2020).
- ⁴ Macpherson, C. C. & Akpinar-Elci, M. Caribbean Heat Threatens Health, Well-being and the Future of Humanity: Table 1. *Public Health Ethics* **8**, 196–208 (2015).
- ⁵ Rataj, E., Kunzweiler, K. & Garthus-Niegel, S. Extreme weather events in developing countries and related injuries and mental health disorders – a systematic review. *BMC Public Health* **16**, (2016).
- ⁶ Azuero, A. J. *et al.* Suicide in the Indigenous Population of Latin America: A Systematic Review. *Revista Colombiana de Psiquiatría* **46**, 237–242 (2017).
- ⁷ Kelman, I. *et al.* A review of mental health and wellbeing under climate change in small island developing states (SIDS). *Environ. Res. Lett.* **16**, 033007 (2021).
- ⁸ Guo, Y., Wen, B., Wu, Y., Xu, R. & Li, S. Extreme temperatures and mortality in Latin America: Voices are needed from the Global South. *Med* **3**, 656–660 (2022).
- ⁹ Allen, C., Beagley, J. & McGushin, A. *Climate Change and Health in Small Island Developing States*. (The Lancet Countdown on Health and Climate Change, 2021).
- ¹⁰ Rojas-Rueda, D., Vaught, E. & Buss, D. Why a New Research Agenda on Green Spaces and Health Is Needed in Latin America: Results of a Systematic Review. *IJERPH* **18**, 5839 (2021).
- ¹¹ Mascayano, F. *et al.* Suicide in Latin America: a growing public health issue. *Revista de la Facultad de Ciencias Medicas* **72**, 295–303 (2015).
- ¹² Parry, L. *et al.* The (in)visible health risks of climate change. *Social Science & Medicine* **241**, 112448 (2019).
- ¹³ Daray, F. M. *et al.* Determinants and geographical variation in the distribution of depression in the Southern cone of Latin America: A population-based survey in four cities in Argentina, Chile and Uruguay. *Journal of Affective Disorders* **220**, 15–23 (2017).

-
- ¹⁴ Lawrance, E. L., Thompson, R., Newberry Le Vay, J., Page, L. & Jennings, N. The Impact of Climate Change on Mental Health and Emotional Wellbeing: A Narrative Review of Current Evidence, and its Implications. *Int Rev Psychiatry* **34**, 443–498 (2022).
- ¹⁵ Corvalan, C. *et al.* Mental health and the global climate crisis. *Epidemiol Psychiatr Sci* **31**, (2022).
- ¹⁶ Charlson, F. *et al.* Climate Change and Mental Health: A Scoping Review. *IJERPH* **18**, 4486 (2021).
- ¹⁷ Hwong, A. R. *et al.* Climate change and mental health research methods, gaps, and priorities: a scoping review. *Lancet Planet Health* **6**, e281–e291 (2022).
- ¹⁸ Charlson, F. *et al.* Global priorities for climate change and mental health research. *Environ Int* **158**, 106984 (2022).
- ¹⁹ Crandon, T. J. *et al.* The clinical implications of climate change for mental health. *Nat Hum Behav* **6**, 1474–1481 (2022).
- ²⁰ Cianconi, P., Betrò, S. & Janiri, L. The Impact of Climate Change on Mental Health: A Systematic Descriptive Review. *Front Psychiatry* **11**, (2020).
- ²¹ Berry, H. L., Bowen, K. & Kjellstrom, T. Climate change and mental health: a causal pathways framework. *Int J Public Health* **55**, 123–132 (2010).
- ²² Aylward, B., Cunsolo, A., Vriezen, R. & Harper, S. L. Climate change is impacting mental health in North America: A systematic scoping review of the hazards, exposures, vulnerabilities, risks and responses. *Int Rev Psychiatry* **34**, 34–50 (2022).
- ²³ Lebel, L. *et al.* Climate change and Indigenous mental health in the Circumpolar North: A systematic review to inform clinical practice. *Transcult Psychiatry* **59**, 312–336 (2022).
- ²⁴ Gale, N. K., Heath, G., Cameron, E., Rashid, S. & Redwood, S. Using the framework method for the analysis of qualitative data in multi-disciplinary health research. *BMC Med Res Methodol* **13**, (2013).